HERRAMIENTA EVALUACIÓN ADHERENCIA GPC SCA

A continuación, se describen cada uno de los ítems incluidos en la **Herramienta de Medición de Síndrome Coronario Agudo**.

Considerando que el abordaje inicial difiere entre el síndrome coronario agudo con elevación del ST y sin elevación del ST, se establece una distinción clara en los parámetros de evaluación para cada caso, facilitando así su correcta identificación y medición.

La escala de calificación es:

0: No aplica (no puntúa)
1: No cumple o cumplimiento mínimo del ítem
4: Cumplimiento adecuado del ítem
5: Cumplimiento total del ítem

Calificación 1 – No cumple / cumplimiento mínimo

Se asigna cuando **no existe registro en la historia clínica**, el registro es **incompleto**, o **no se evidencia la realización o solicitud del estudio/intervención indicada según el ítem evaluado**. También aplica cuando la información consignada es insuficiente para verificar el cumplimiento del criterio.

Calificación 4 – Cumplimiento adecuado

Se asigna cuando **existe registro en la historia clínica que evidencia el cumplimiento del criterio evaluado**, incluyendo la solicitud del estudio, intervención o valoración correspondiente; sin embargo, **la información puede ser parcial o no incluir todos los elementos recomendados por la guía**, aunque permite verificar razonablemente que la conducta fue realizada.

Calificación 5 – Cumplimiento total

Se asigna cuando **el criterio se cumple completamente y se encuentra claramente documentado en la historia clínica**, incluyendo todos los componentes recomendados por la guía de práctica clínica (registro clínico completo, solicitud o realización del estudio correspondiente, interpretación cuando aplique y coherencia con el contexto clínico del paciente).

- **Ítems de evaluación**

ÍTEM DE EVALUACIÓN	CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Caracterización del dolor torácico	Se realiza y registra en la historia clínica la caracterización clínica del dolor torácico, incluyendo inicio, localización, irradiación, duración, factores desencadenantes o de alivio y síntomas asociados.
2. Electrocardiograma inicial	Se solicita y realiza electrocardiograma de 12 derivaciones durante la valoración inicial del paciente con dolor torácico.
3. Solicitud e interpretación de troponina	Se solicita troponina cardíaca y se documenta su resultado e interpretación clínica (negativa, positiva o necesidad de repetir).
4. Manejo farmacológico inicial	Se inicia manejo farmacológico indicado para síndrome coronario agudo, incluyendo antiagregación y anticoagulación según corresponda (ej. AAS, clopidogrel, anticoagulante).
5. Estratificación del riesgo	Se aplica y registra una escala de estratificación de riesgo cardiovascular validada (ej. GRACE, TIMI u otra).
6. Inicio oportuno del tratamiento	Se inicia de manera oportuna el tratamiento indicado en pacientes con diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación del ST (<1hora), incluyendo antiagregación plaquetaria, anticoagulación y otras medidas terapéuticas según el contexto clínico.

- Definición operativa de ítems de evaluación (1-4-5)

1. Caracterización del dolor torácico

Ítem de evaluación
Se realiza y registra en la historia clínica la caracterización clínica del dolor torácico, incluyendo inicio, localización, irradiación, duración, factores desencadenantes o de alivio y síntomas asociados.

1 – No cumple
No se documenta la descripción del dolor torácico o la información es insuficiente para caracterizarlo.

4 – Cumple adecuadamente
Se registra características del dolor torácico, pero falta parámetros de descripción relevantes.

5 – Cumple totalmente
Se documenta una caracterización completa del dolor torácico con los principales elementos clínicos.

2. Valoración de electrocardiograma (ECG) en la consulta inicial

Ítem de evaluación
Se interpreta **electrocardiograma de 12 derivaciones durante la valoración inicial** del paciente con dolor torácico.

1 – No cumple
No se evidencia interpretación de ECG o hasta la valoración se solicita ECG (aumentando el tiempo de atención en SCA)

4 – Cumple adecuadamente
Se realiza ECG, pero no se registra claramente su interpretación.

5 – Cumple totalmente
Se registra interpretación completa del ECG durante la valoración inicial.

SÍNDROME CORONARIO SIN ELEVACIÓN DE ST

3. Solicitud e interpretación de troponina

Ítem de evaluación
Se solicita troponina cardíaca y se documenta su **interpretación clínica (negativa, positiva o necesidad de repetir)**.

1 – No cumple
No se solicita troponina o no se registra su resultado.

4 – Cumple adecuadamente
Se solicita troponina, pero no se documenta claramente su interpretación clínica o seguimiento.

5 – Cumple totalmente
Se solicita troponina y se registra su resultado e interpretación clínica, incluyendo repetición cuando está indicado.

4. Inicio de manejo anti isquémico

Ítem de evaluación
Se inicia manejo farmacológico indicado para síndrome coronario agudo, incluyendo **antiagregación y estatina**.

1 – No cumple
No se evidencia inicio de manejo farmacológico indicado.

4 – Cumple adecuadamente
Se prescribe alguno de los medicamentos indicados, pero el manejo es incompleto.

5 – Cumple totalmente
Se documenta manejo farmacológico completo acorde al diagnóstico clínico.

5. Inicio de manejo anticoagulante

Ítem de evaluación
Se inicia manejo farmacológico indicado para síndrome coronario agudo, incluyendo anticoagulación y se ajusta de acuerdo a edad/TFG.

1 – No cumple
No se evidencia ajuste de dosis cuando está indicado o no se documenta el tratamiento.

4 – Cumple adecuadamente
Se prescribe tratamiento anticoagulante, pero no se evidencia claramente el ajuste según las condiciones del paciente.

5 – Cumple totalmente
Se prescribe anticoagulación y se documenta adecuadamente el ajuste de dosis según edad o función renal.

6. Estratificación del riesgo

Ítem de evaluación
Se aplica y registra una escala de estratificación de riesgo cardiovascular (ej. GRACE, TIMI, HEART, EDACS).

1 – No cumple
No se realiza ni se registra evaluación del riesgo.

4 – Cumple adecuadamente
Se menciona evaluación del riesgo, pero no se documenta la escala o su resultado.

5 – Cumple totalmente
Se aplica una escala validada y se registra claramente el resultado o categoría de riesgo.

7. Inicio oportuno del tratamiento

Ítem de evaluación

Se inicia de manera oportuna el tratamiento indicado en pacientes con diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación del ST (<1hora), incluyendo antiagregación plaquetaria, anticoagulación y otras medidas terapéuticas según el contexto clínico.

1 – No cumple
No se evidencia inicio del tratamiento indicado o el inicio es tardío sin justificación clínica documentada.

4 – Cumple adecuadamente
Se inicia tratamiento, pero no queda claramente documentado el momento de inicio o el manejo es parcial.

5 – Cumple totalmente
Se evidencia inicio oportuno del tratamiento recomendado y queda claramente documentado en la historia clínica.

SÍNDROME CORONARIO CON ELEVACIÓN DE ST

3. Inicio de manejo anti isquémico

Ítem de evaluación
Se inicia manejo farmacológico indicado para síndrome coronario agudo, incluyendo antiagregación y estatina.

1 – No cumple
No se evidencia inicio de manejo farmacológico indicado.

4 – Cumple adecuadamente
Se prescribe alguno de los medicamentos indicados, pero el manejo es incompleto.

5 – Cumple totalmente
Se documenta manejo farmacológico completo acorde al diagnóstico clínico.

4. Inicio de manejo anticoagulante

Ítem de evaluación
Se inicia manejo farmacológico indicado para síndrome coronario agudo, incluyendo anticoagulación y se ajusta de acuerdo a edad/TFG.

1 – No cumple
No se evidencia ajuste de dosis cuando está indicado o no se documenta el tratamiento.

4 – Cumple adecuadamente
Se prescribe tratamiento anticoagulante, pero no se evidencia claramente el ajuste según las condiciones del paciente.

5 – Cumple totalmente
Se prescribe anticoagulación y se documenta adecuadamente el ajuste de dosis según edad o función renal.

5. Inicio oportuno del tratamiento

Ítem de evaluación

Se inicia de manera oportuna el tratamiento indicado en pacientes con diagnóstico de síndrome coronario agudo con elevación del ST (<1hora), incluyendo antiagregación plaquetaria, anticoagulación, fibrinólisis o ICP según el contexto clínico.

1 – No cumple
No se evidencia inicio del tratamiento indicado o el inicio es tardío sin justificación clínica documentada.

4 – Cumple adecuadamente
Se inicia tratamiento, pero no queda claramente documentado el momento de inicio o el manejo es parcial.

5 – Cumple totalmente
Se evidencia inicio oportuno del tratamiento recomendado y queda claramente documentado en la historia clínica.

6. Fibrinólisis

Ítem de evaluación

Se indica y documenta terapia fibrinolítica en pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del ST cuando la intervención coronaria percutánea no está disponible dentro del tiempo recomendado o según criterio clínico, evidenciándose en la historia clínica la indicación, el medicamento utilizado y el momento de administración.

1 – No cumple
No se evidencia indicación de fibrinólisis en paciente candidato o no se documenta la conducta adoptada.

4 – Cumple adecuadamente

Se realiza la fibrinólisis como opción terapéutica, pero falta registro de información de control y seguimiento tras medicación en la historia clínica.

5 – Cumple totalmente

Se documenta claramente la indicación y administración de fibrinólisis en paciente candidato, incluyendo el medicamento y el momento de inicio del tratamiento.